·指南与共识·

老年髋部骨折患者出院准备服务计划专家共识

中国脆性骨折联盟　北京围手术期医学学会老年骨科护理与康复专业委员会　湖南省护理学会骨科专业委员会

【摘要】出院准备服务是帮助患者从医院平稳地过渡到家庭或照护机构，保证护理延续性的关键环节。如果出院准备不足，会导致患者身体功能恢复缓慢，容易引起再次骨折甚至死亡等不良结局。通过标准化的出院准备服务计划，能够改善患者相关不良结局。本共识基于临床循证证据，结合骨科护理实践经验，收集相关领域专家意见，聚焦于老年髋部骨折患者的特点和出院准备服务的整个流程，旨在提升老年髋部骨折患者的远期功能恢复水平、降低其再入院率与不良事件风险，改善生活质量，并为临床医务人员提供规范化的实践指导。

【关键词】髋部骨折；老年人；出院准备服务计划；专家共识

实践指南注册：国际实践指南注册与透明化平台（PREPARE-2026CN922）

基金项目：耶鲁李氏基金会教师资助计划（2024LFG01）；雅礼协会 2023 中国社区卫生服务计划（2023YC02）

［中图分类号］　R684　　［文献标志码］　A

Expert consensus on discharge preparation service plan for elderly patients with hip fractures

China Fragility Fracture Network, Elderly Orthopedic Nursing and Rehabilitation Special Committee of Beijing Perioperative Medicine Society, Orthopaedic Committee of Hunan Nursing Association

Corresponding authors: Jia Yunyang, 100035 Beijing, Department of Orthopaedic Trauma, Beijing Jishuitan Hospital, Capital Medical University, E-mail: beautiful6504@sina.com; Peng Lingli, 410008 Changsha, Teaching and Research Section of Clinical Nursing, Xiangya Hospital Central South University, E-mail: lingli.peng@csu.edu.cn

【Abstract】Discharge preparation services are a crucial link to help patients smoothly transition from hospital to home or care institutions and ensure the continuity of care. Insufficient discharge preparation can lead to slow recovery of patients′ physical functions, and may even cause adverse outcomes such as re-fracture or death. Through standardized discharge preparation service plans, the related adverse outcomes of patients can be improved. This consensus is based on clinical evidence-based data, combined with the practical experience of orthopedic nursing, and collects the opinions of experts in related fields. The entire text focuses on the characteristics of elderly patients with hip fractures and the entire process of discharge preparation services. It aims to improve the long-term functional recovery level of elderly patients with hip fractures, reduce their readmission rate and the risk of adverse events, improve their quality of life, and provide standardized practical guidance for clinical medical staff.

【Key words】Hip fracture; Aged; Discharge preparation service plan; Expert consensus

Practice Guideline Registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2026CN922)

Fund program: Yale Li Foundation Faculty Grant Program (2024LFG01); Yale-China Association 2023 Chia Community Health Services Program (2023YC02)

DOI: 10.19548/j.2096-269x.2026.05.002

通信作者：贾云洋，100035 北京，首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科，E-mail：beautiful6504@sina.com；彭伶丽，410008 长沙，中南大学湘雅医院临床护理学教研室，E-mail：lingli.peng@csu.edu.cn

老年髋部骨折是一种常见的骨质疏松性骨折，具有高发病率、高致死率、高致残率、高医疗费用的特点[1]。随着人口老龄化进程的持续加快，其患病率不断上升，已成为全球面临的重大公共卫生挑

战。据预测，到 2050 年，全球髋部骨折病例数将增长至 626 万，半数以上的病例集中在亚洲地区，尤其是中国[2-3]。研究显示，约有 50% 的髋部骨折患者会出现永久性残疾，25% 的患者无法恢复至骨折前的活动能力，20% 的患者需过渡到长期疗养院护理[4]。此外，骨折发生后 6 个月内病死率为 10%~20%，1 年内病死率高达 20%~30%[5]，上述问题凸显了老年髋部骨折患者在康复过程中面临的挑战。手术治疗是髋部骨折的首选方法[6]，术后康复过程漫长而复杂，直接关系到患者的长期功能恢复。随着医疗卫生资源持续优化和分级诊疗体系的不断完善，外科手术患者的平均住院时间呈现缩短趋势[7]，康复场所逐渐从医院向医疗照护机构、社区及家庭延伸。患者在转诊至其他护理机构的过程中，常面临护理服务连续性中断的问题[8]。如何在不同照护场所之间实现衔接，保障康复干预的持续性与有效性，已成为影响患者远期功能恢复与生活质量的关键问题。

出院准备服务计划是指多学科医护团队在入院早期阶段，对患者及其家庭照顾者进行全面评估和筛查，明确个性化出院需求并制定出院计划，协助患者在完成必要治疗后，安全且顺利地返回家中，或转入院外照护机构[9-10]。出院准备服务能够促进患者早期功能恢复，降低术后早期并发症发生风险，缩短住院天数，降低非计划性再入院率，并提高患者医疗服务满意度[11-12]。目前，我国已发布《老年患者出院准备服务专家共识（2019 版）》[13]，为老年患者出院准备服务提供了总体指导。然而，老年髋部骨折患者具有功能恢复周期长及再骨折风险高等特点，现有共识难以满足其专科化照护需求，有必要在其基础上进一步细化与拓展，形成更具针对性和可操作性的老年髋部骨折患者出院准备服务计划专家共识。因此，编写专家组整合最新循证证据并结合临床实践经验，经过两轮德尔菲专家函询修改完善后，最终形成符合我国临床实际的老年髋部骨折患者出院准备服务计划专家共识，旨在为其规范实施提供指导。本共识采用乔安娜·布里格斯研究所（Joanna Briggs institute，JBI）证据预分级及证据推荐级别系统（2014 版）将纳入的证据分为 Level 1~5 级（Level 1 最高，Level 5 最低）[14]；并由专家依据证据的 FAME 结构对证据的推荐强度做出判定，分为 A 级推荐（强推荐）和 B 级推荐（弱推荐）两个等级（表 1~4）。本共识已在国际实践指南注册与透明化平台（practice guideline registration for transparency，PREPARE）注册（PREPARE-2026CN922）。

表 1　JBI 2014 版干预性研究证据预分级[14]

证据等级	设计类型举例	描述
Level 1	RCT/实验性研究	1a—多项 RCT 的系统评价
		1b—多项 RCT 及其他干预性研究的系统评价
		1c—单项随机对照试验（RCT）
		1d—准随机对照试验
Level 2	类实验性研究	2a—多项类实验性研究的系统评价
		2b—多项类实验性研究与其他低质量干预性研究的系统评价
		2c—单项前瞻性有对照组的类实验性研究
		2d—前后对照/回顾性对照的类实验性研究
Level 3	观察性—分析性研究	3a—多项队列研究的系统评价
		3b—多项队列研究与其他低质量观察性研究的系统评价
		3c—单项有对照组的队列研究
		3d—单项病例对照研究
		3e—单项无对照组的观察性研究
Level 4	观察性—描述性研究	4a—多项描述性研究的系统评价
		4b—单项横断面研究
		4c—病例系列研究
		4d—个案研究
Level 5	专家意见/基础研究	5a—对专家意见的系统评价
		5b—专家共识
		5c—基础研究/单项专家意见

注：RCT 为随机对照试验

表 2　JBI 2014 版质性研究证据预分级[14]

证据等级	研究设计举例	描述
Level 1	混合设计研究的系统评价	1 —多项质性研究或混合设计研究的系统评价
Level 2	质性研究的 Meta 整合	2 —多项质性研究或混合设计研究的整合
Level 3	描述性质性研究、现象学研究、扎根理论研究、人种学研究等	3 —单项质性研究
Level 4	对专家意见的系统评价	4 —对专家意见的系统评价
Level 5	单项专家意见	5 —专家意见

一、出院准备服务的实施主体与职责

1. 多学科团队协作：老年髋部骨折患者兼具高龄、多病共存、功能衰退及社会支持不足等复杂特点[5, 15]，其出院准备需求涉及医疗、康复、护理、营养及社会支持等多个维度。构建一个融合医学管理、

表 3　JBI 的证据 FAME 结构(JBI FAME Scale)[14]

证据的 FAME 结构	描述
证据的可行性 F-Feasibility	开展该项实践的成本效果如何? 开展该项实践所需的资源是否具有可及性? 是否有足够的经验和能力开展该实践?
证据的适宜性 A-Appropriateness	该实践方式是否在文化上是可接受? 该实践方式是否可在大多数人群中转化或应用? 该实践方式是否适合于各种不同的场景?
证据的临床意义 M-Meaningfulness	应用该实践是否与患者的积极体验相联系? 应用该实践是否不会导致患者出现不良体验?
证据的有效性 E-Effectiveness	应用该实践是否获益? 该实践是否具有安全性?

物理治疗、营养支持、社会服务及心理干预的多学科团队,可以更好地促进患者康复[16]。研究显示,依托多学科团队早期支持实施出院准备服务,可以缩短髋部骨折术后患者住院时间,促进早期功能恢复,并降低再入院率[17]。全球脆性骨折联盟呼吁对老年髋部骨折患者开展急性多学科护理以帮助其恢复功能并预防再次骨折[18]。构建多学科团队,应当明确每个团队成员在出院计划中的角色和责任,确定哪些成员将负责哪项任务,并概述明确的期望[19]。

推荐意见 1:组建多学科团队,成员应包括骨科医师、临床护理专家、康复科医师、协调者以及其他学科专业人员(营养师、药剂师、社会工作者、转介机构负责人)等。团队间应明确个人职责,及时沟通,紧密合作。(证据等级:1a,推荐等级:强推荐)

具体职责包括:(1)骨科医师负责疾病诊疗、出院后医疗需求评估、决定出院日期、药物重整、告知复查相关事项并参与制定随访计划;(2)护士长负责科室护士出院准备服务相关知识培训、持续改进科室出院准备服务质量并协调多部门之间的合作,确保护理措施连续性;(3)责任护士作为出院协调员,负责患者初筛、确认服务对象、复评、需求评估、照护指导、转介患者及随访追踪;(4)康复科医师提供康复运动计划与康复技巧指导;(5)营养师提供饮食设计、营养宣教和咨询;(6)药剂师负责药物重整、提供用药指导与咨询;(7)社会工作者提供社会资源和辅助用具租借的相关信息咨询、根据患者需求协助联系与安排、结合医院职责调整需求;(8)转介机构负责人(如医院、社区、养老院)负责转接患者、接收转介信息并做好转入准备。

2. 患者及家庭照顾者参与:老年髋部骨折患者由于独立活动能力下降和认知状态变化,康复阶段通常需要家庭照顾者提供日常生活帮助、情感和社会支持等[20-21],家庭照顾者是患者出院回家后的主要照护力量。研究表明,未根据患者需求定制的出院过渡计划会让患者产生不确定性而引发焦虑[22],未考虑家庭照顾者需求的照护计划会导致计划执行困难、照护质量下降、再入院风险增高[23]。充分考虑患者及其家庭照顾者的出院需求,能够有效提升出院准备度并实现安全顺利的医疗过渡[11]。

推荐意见 2:鼓励患者及其家庭照顾者积极参与出院计划的制定与实施。(证据等级:1a,推荐等级:强推荐)

二、住院期间的出院准备措施

1. 高危人群筛查与评估:确定服务对象是开展出院准备服务的第一步,髋部骨折患者出院照护需求存在差异性,应在入院 24 h 内对所有住院患者进行评估,确定出院服务需求高危人群[24]。出院服务需求高危人群是指经筛选后有出院照护需求或有延迟出院风险因素的患者[13]。国外对出院高风险患者的筛查中,较具代表性的工具是 Blaylock 风险评估筛查量表[25],国内多采用出院计划综合需求评估量表进行评估[26]。患者的疾病护理是一个动态变化的过程,不仅要全面、综合地评估患者各方面的状况,更要动态更新其评估结果以便及时调整出

表 4　JBI 2014 版证据推荐级别[14]

推荐级别	判断标准	表达式举例
A 级推荐:强推荐	1. 明确显示干预措施利大于弊或弊大于利 2. 高质量证据支持应用 3. 对资源分配有利或无影响 4. 考虑了患者的价值观、意愿和体验	卫生保健专业人员应该为社区 2 型糖尿病患者提供血糖控制自我管理方式方面的书面信息
B 级推荐:弱推荐	5. 干预措施利大于弊或弊大于利,尽管证据尚不够明确 6. 有证据支持应用,尽管证据质量不够高 7. 对资源分配有利、或无影响、或有较小影响 8. 部分考虑,或并未考虑患者的价值观、意愿和体验	卫生保健专业人员可向社区 2 型糖尿病患者演示胰岛素注射笔的使用方式

院准备服务计划[27]。

推荐意见 3：在患者入院 24 h 内完成高危人群筛查，建议使用出院计划综合需求评估量表确定出院服务需求高危人群。评估维度包括患者身体功能、疾病问题、认知状态、再入院风险、心理状况、居住环境、家庭照护能力及经济状况等，并根据健康状态变化动态更新评估结果。（证据等级：2a，推荐等级：强推荐）

2. 制定出院计划：出院计划的制定是一个复杂的过程，确认需要开展服务的对象后应尽早根据其需求和实际情况开始制定计划[28]。出院计划的内容应由多学科团队基于患者和照顾者的多维度需求进行制定[29]，范围应涵盖患者从入院到随访的整个过程。患者的情况会随着住院期间的治疗而不断变化，应持续评估患者的需求并及时调整出院计划[24]。

推荐意见 4：出院计划应该在入院后 72 h 内开始制定，内容包括：入院后早期评估、出院前再评估、确定出院目的地、出院日期和时间、出院指导内容、出院转介信息、出院后延续护理内容、持续随访时机和内容等。出院计划根据患者情况进行动态调整，最终版于出院前 48 h 确定。（证据等级：1a，推荐等级：强推荐）

3. 出院目的地与转介管理：确认患者的身体状况达到出院条件时，应遵循规范化流程，依据患者的医疗需求、功能状态、社会因素等选择适宜的照护机构[30]。为了确保患者能够安全出院回家或转至其他照护机构，必须充分考虑患者的急性和慢性医学问题、康复潜力及决策能力[31]。信息交换对于护理机构之间的高质量护理过渡至关重要，医院和其他照护机构之间的信息交流不足或不及时可能导致治疗差异、决策错误，甚至再次住院[32]。完整、及时、可靠的信息转介有助于照护机构做好接纳患者的准备，提高护理过渡的质量与安全[33]。

推荐意见 5：根据患者功能恢复情况确认出院目的地及出院转运方式：具备自我管理能力者可居家照护；若患者经评估日常生活能力受限、髋关节恢复情况欠佳，经患者及家属同意后出院至院外照护机构。至少于出院前 2 d 通知接收方，并通过信息化工具（如电子健康记录共享系统、信息转介管理平台等）完成规范化的信息交接，确保出院小结、用药清单、康复目标等关键信息的完整、准确与及时传递，以促进出院后照护的连续性与安全性。（证据等级：5b，推荐等级：弱推荐）

推荐意见 6：转介时需向家属提供标准化信息包，包括出院指导的具体内容（用药、康复锻炼）、家庭无障碍环境的布置、复查及随访的时间地点及内容、社区资源的获取方式、相关机构信息（如基层医疗机构、康复机构、长期照护机构等）。（证据等级：5b，推荐等级：弱推荐）

推荐意见 7：转介时需向照护机构提供标准化信息包，包括出院小结、出院后用药清单，住院期间药物调整情况，出院后需按时完善的检查、认知能力、精神或心理状态、身体功能状态、问题和注意事项、患者的治疗目标和偏好、患者所在病房的联系方式、随访预约和随访计划，以便院外照护机构开始制订出院后服务计划。（证据等级：5b，推荐等级：弱推荐）

三、出院前评估

1. 评估时机：出院前的再次评估可以判断出院计划的各环节是否准备就绪。出院前 24 h 是保障患者实现平稳过渡的核心阶段，此期间患者所有的出院准备工作都应落实到位，以确保在出院当天或出院后向患者提供服务时不会出现延误[24]。核查内容应包括出院信息、交通转运安排、药物管理、家庭环境等[34]。

推荐意见 8：在出院前 24 h 内完成复评核查确认，并联系患者的家属或照护者、全科医生、院外照护机构，确认患者出院所需物品、医疗器械准备情况、交通/转运工具、家庭环境准备等均已安排妥当。（证据等级：5b，推荐等级：弱推荐）

2. 评估内容：对患者状况及可用资源开展多维度评估，确认其是否符合出院标准，是降低患者再入院率、减少出院后不良事件发生的重要环节[35]。评估范围应涵盖患者的医疗与照护需求（身体状况、认知状况、功能状态）、家庭支持状况（居住环境、照护能力、支持系统）、社区资源可及性与适配性（是否可以帮助患者实现持续医疗），从而为制定科学、可行的出院计划提供可靠依据[28]。

推荐意见 9：应在出院前完成多维度评估，内容包括：（1）患者评估：通过 Barthel 指数和 Harris 髋关节评分（Harris hip score，HHS）分别评估患者的日常生活活动能力和髋关节功能恢复情况，结合 Morse 跌倒评估量表和骨折风险评估工具分析其跌倒与再骨折风险，并运用 LACE 风险模型评估再入院风险。另外，还需评估患者的骨质疏松风险、认知状况、心理健康、伤口、管道情况、营养、疼痛、静脉血栓栓塞症风险等；（2）家庭评估：家庭居住环境（卫生间地面、过道、求助系统）是否对患者的康复有

利、家庭照顾者的照护能力和意愿、支持系统与经济资源，对有需要的患者进行家庭访视；(3)出院后预期的照护需求：辅助性医疗器具或设备、院外医疗和护理支持、转诊或转介协助；(4)资源评估：确认社区医疗资源可及性(如居家护理服务、日间照护服务、康复辅助用具租借服务等)，是否能满足患者的需求。(证据等级：2a，推荐等级：强推荐)

四、规范化出院指导内容

1. 出院服务开展时机与方式：对患者和家属尽早开展系统化、多样化的出院指导，帮助他们掌握必要的照护知识与技能、培养长期照护所需的积极态度，为出院做好充分准备[28]。护理过渡期间沟通不畅会导致患者和照顾者的不信任、照顾者焦虑和抑郁、再入院率提高、康复延迟等，选择高效合适的沟通方法传递信息可以让患者和家庭照顾者清晰、完整地理解出院指导内容[36]。

推荐意见 10：在出院前 48 h 内开展出院准备服务，及时告知患者及照顾者随访预约和随访计划。多学科团队以口头、书面或视频形式开展出院指导，指导语需通俗易懂，必要时重复内容，并通过教学回授法确认理解。(证据等级：1a，推荐等级：强推荐)

2. 核心指导内容：出院指导内容应以患者为中心，涵盖患者健康信息以及治疗内容，信息全面且准确，能够帮助患者及其家属清晰了解出院后的健康管理重点[37]。老年髋部骨折患者术后康复周期长，出院后仍面临诸多挑战：一方面，患者处于压疮、深静脉血栓形成等并发症的高危期，且肢体功能障碍持续存在；另一方面，患者与家属常因康复知识及技能的不足，导致康复依从性不佳。目前，患者普遍存在用药依从性差、康复训练认知不足、营养不良、跌倒恐惧等问题[38-41]，应该针对性地做出指导以提高患者的治疗依从性并降低跌倒和再骨折风险。提供延续性护理指导(如药物使用方法、康复训练计划、并发症预防与处理方法、饮食指导、心理指导)可以有效提高患者的治疗依从性，提升康复效果[42]。

推荐意见 11：延续性护理指导：持续开展健康促进措施；手术部位的观察方法(包括手术切口红肿、渗液、疼痛加剧等的识别与报告)；术后并发症/病情恶化的应急处理(如假体脱位、二次骨折、手术部位感染、谵妄、静脉血栓栓塞症、便秘等)；医疗设备和辅助器具(如助行器、拐杖、轮椅等)的使用方法。(证据等级：1b，推荐等级：强推荐)

推荐意见 12：用药指导：告知患者用药种类及各种药物的用法、用量、疗效及不良反应。检查出院带药并根据医生的医嘱指导患者使用维生素 D 及钙剂。(证据等级：1b，推荐等级：强推荐)

推荐意见 13：家庭康复训练和活动指导：康复科医生根据患者疾病状况、手术方式，为患者提供合适的家庭康复锻炼的方式、技巧及注意事项，并提供图文或视频形式的康复指导材料。内容应包括体位转移训练、早期下床、即刻负重、四肢肌肉力量训练、步态训练、平衡功能训练、本体感觉训练、关节活动度训练、有氧及拉伸运动等，改善其功能预后、预防跌倒，直到完成康复目标。(证据等级：2a，推荐等级：强推荐)

推荐意见 14：饮食指导：根据患者情况制定个性化饮食计划。(证据等级：2b，推荐等级：强推荐)

推荐意见 15：心理康复指导：为患者提供心理干预，积极发现问题的同时减少患者的不良情绪，保持患者心态健康，提升康复信心。关注照顾者的心理健康，给予积极的心理支持。(证据等级：1a，推荐等级：强推荐)

五、出院后随访管理

1. 随访时机：出院后的随访与追踪可以及时察觉患者康复过程中出现的新问题并予以针对性指导，是动态评估病情变化、科学优化治疗方案的关键环节，有助于提高患者的治疗依从性和规范性，确保出院准备服务的延续性[43]。患者出院后的最初几天至 1 周内，病情往往处于相对不稳定的阶段；出院后的 30 d 内更是患者并发症预防和管理的关键时期，应重点关注患者的身体状态与康复情况[44]。骨折后 1~6 个月是功能恢复的黄金时期，加强这一时期的随访可以优化术后康复效果，改善远期预后[45]。

推荐意见 16：建议为患者提供 120~180 d 的随访，指导出院患者接受定期随访，以采取措施降低再次入院的风险。建议于患者出院后 3~7 d 内进行首次随访服务，具体日期可在出院当天确定。于出院后 2 周或 1 个月进行第 2 次随访服务，之后可根据患者的康复进展、风险等级及机构资源，制定个体化的随访频率，但建议至少在第 3 个月和第 6 个月进行关键节点评估。(证据等级：5b，推荐等级：弱推荐)

2. 随访内容：标准化、系统化、科学化的随访内容有助于全方位评估并解决患者健康问题，有效提高患者生活质量。随访清单应符合老年髋部骨折术后患者疾病特点，充分考虑各阶段的照护需求，具有一定的临床实践指导性[46]。研究表明，HHS 是

髋部骨折术后二次骨折的预警指标之一，完善HHS有利于识别出易发术后二次骨折的高危人群并降低髋部再发骨折的风险[47]，应重点关注这一内容。

推荐意见17：追踪重点包括：(1)评估髋关节功能的恢复情况(HHS)；(2)核查患者的用药情况；(3)确认患者出院后的复诊安排；(4)核查和协调居家或社区医疗服务；(5)讨论新出现健康问题的解决方案；(6)患者对于目前所接受的照护是否满意，患者是否还有其他未被满足的照护需求；(7)患者是否再入院及其入院原因。(证据等级：2a，推荐等级：强推荐)

老年髋部骨折患者出院过渡是一个复杂且充满挑战的过程，其出院准备不足与再入院率、功能恢复及并发症风险密切相关。本共识围绕出院准备服务实施的主体与职责、住院期间的准备措施、出院前评估、规范化出院指导内容、出院后随访管理5个方面形成了老年髋部骨折患者出院准备服务计划的完整流程，旨在为临床实践提供规范化的护理指导与参考依据。出院服务并非一个孤立的环节，而是一个以患者为中心、多学科协作、全程动态化管理的过程。医护人员应该认识到结构化出院准备服务计划的重要价值，积极推动其在临床场景的实践应用，以切实保障患者安全，进一步改善患者远期康复结局与生活质量。

执笔者

杨滨毓(中南大学湘雅医院临床护理学教研室 中南大学湘雅护理学院)；黄淳(中南大学湘雅医院临床护理学教研室)；杨佳琪(中南大学湘雅医院骨科)

指导专家组(按姓氏汉语拼音字母排序)

高远(解放军总医院第一医学中心护理部)；林涨源(中南大学湘雅医院骨科)；杨明辉(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科)

编写专家组(按姓氏汉语拼音字母排序)

陈亚萍(中国医学科学院北京协和医院骨科)；戴宇(中南大学湘雅二医院骨科)；邸铁涛(贵州中医药大学第二附属医院骨科)；冯乐玲(宁波市第六医院骨科)；傅育红(无锡市第九人民医院骨科)；黄天雯(中山大学附属第一医院骨科)；贾云洋(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科)；孔丹(解放军总医院第一医学中心骨科)；鲁建丽(浙江大学医学院附属第一医院骨科)；罗春梅(陆军军医大学第二附属医院骨科)；闵燕(南昌大学第一附属医院护理部)；宁宁(四川大学华西医院骨科)；彭伶丽(中南大学湘雅医院临床护理学教研室)；邱海玲(湖南省人民医院骨科)；任英(浙江大学医学院附属第二医院骨科)；王琦(广西医科大学第一附属医院骨科)；王莹(中南大学湘雅三医院骨科)；吴松梅(河南省洛阳正骨医院护理部)；杨佳琪(中南大学湘雅医院骨科)；张萍(南方医科大学南方医院骨科)；张瑞英(广东省人民医院骨科)

参 考 文 献

[1] 陈旭娟, 朱晓萍, 田梅梅, 等. 老年髋部骨折术后患者肺部感染预测模型的构建及验证[J]. 中华护理杂志, 2021,56(5):659-666.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2021.05.003.

[2] Cooper C, Campion G, Melton LJ 3rd. Hip fractures in the elderly: a world-wide projection[J]. Osteoporos Int, 1992,2(6):285-289.DOI:10.1007/BF01623184.

[3] Zhang Chenghui, Feng Jingnan, Wang Shengfeng, et al. Incidence of and trends in hip fracture among adults in urban China: a nationwide retrospective cohort study[J]. PLoS Med, 2020,17(8):e1003180.DOI:10.1371/journal.pmed.1003180.

[4] Zheng Wei, Cai Qianying, Zhang Changqing, et al. One-year functional outcomes following geriatric hip fracture: a prospective cohort analysis[J]. Orthop Surg, 2025,17(7):2130-2140.DOI:10.1111/os.70081.

[5] 刘刚, 杨明辉, 张京, 等.《老年髋部骨折诊疗与管理指南(2022年版)》解读[J]. 骨科临床与研究杂志, 2023,8(2):73-76.DOI:10.19548/j.2096-269x.2023.02.002.

[6] 王琳珏, 郭锐. 老年髋部骨折手术治疗的研究进展[J]. 现代诊断与治疗, 2021,32(9):1368-1370.

[7] 熊丹莉, 潘路晨, 杨赛, 等. 出院准备计划方案在老年肠造口患者中的应用研究[J]. 护理学杂志, 2023,38(19):100-104.DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2023.19.100.

[8] Ko Y J, Lee J H, Baek S. Discharge transition experienced by older Korean women after hip fracture surgery: a qualitative study[J]. BMC Nurs, 2021,20(1):112.DOI:10.1186/s12912-021-00637-9.

[9] Hall K K, Shoemaker-Hunt S, Hoffman L, et al. Making healthcare safer Ⅲ: a critical analysis of existing and emerging patient safety practices[M]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2020.

[10] 黄淳, 郑西林, 彭伶丽, 等. 老年髋部骨折患者出院准备服务计划的最佳证据总结[J]. 华西医学, 2023,38(10):1503-1510.DOI:10.7507/1002-0179.202308223.

[11] 王婉. 出院准备服务在老年髋部骨折患者术后康复中的应用研究[D]. 内蒙古医科大学, 2020.

[12] 李珊, 李欣潞, 郝德慧, 等. 基于出院需求评估结果制订的护理出院计划对老年髋部骨折术后患者出院准备度、出院指导质量及早期康复效果的影响[J]. 广西医学, 2024,46(7):1031-1038.DOI:10.11675/j.issn.0253-4304.2024.07.14.

[13] 孙超, 奚桓, 李峥, 等. 老年患者出院准备服务专家共识(2019版)[J]. 中华护理杂志, 2020,55(2):220-227.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2020.02.011.

[14] 王春青, 胡雁. JBI证据预分级及证据推荐级别系统(2014版)[J]. 护士进修杂志, 2015,30(11):964-967.DOI:10.16821/j.cnki.hsjx.2015.11.002.

[15] 徐云明, 吴刚, 刁仁月, 等. 老年脆性髋部骨折患者术后并发症及日常活动能力的危险因素分析及风险预测模型建立[J]. 中国骨伤, 2026,39(7):720-730.

[16] Falaschi P, Marsh D, eds. Orthogeriatrics: the management of older patients with fragility fractures[M]. Cham (CH): Springer, 2021.
[17] 段文静. 老年髋部骨折术后多病共存患者出院准备度现状及影响因素分析[D]. 安徽中医药大学, 2025.
[18] Dreinhöfer K E, Mitchell P J, Bégué T, et al. A global call to action to improve the care of people with fragility fractures[J]. Injury, 2018,49(8):1393-1397.DOI:10.1016/j.injury.2018.06.032.
[19] Quality AFHR. Care transitions from hospital to home: IDEAL discharge planning[EB/OL]. (2013-06-15)[2025-10-15]. https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/engagingfamilies/strategy4/index.html.
[20] Fernández-González M, Lozano-Lozano M, Martín-Martín L, et al. Is a telerehabilitation programme for older adults with hip fracture associated with burden of family caregivers who provide support?[J]. Digit Health, 2023, 9: 20552076231213574. DOI: 10.1177/20552076231213574.
[21] Rocha P, Baixinho C L, Albuquerque C, et al. Nurses' perspective on transitional care for older person with hip fracture: a qualitative study[J]. Int J Orthop Trauma Nurs, 2025, 58: 101214.DOI:10.1016/j.ijotn.2025.101214.
[22] Brooks L, Stolee P, Elliott J, et al. Transitional care experiences of patients with hip fracture across different health care settings[J]. Int J Integr Care, 2021,21(2):2.DOI:10.5334/ijic.4720.
[23] Saletti-Cuesta L, Tutton E, Langstaff D, et al. Understanding informal carers' experiences of caring for older people with a hip fracture: a systematic review of qualitative studies[J]. Disabil Rehabil, 2018,40(7):740-750.DOI:10.1080/09638288. 2016.1262467.
[24] 汪晖, 王颖, 刘于, 等. 住院患者出院计划关键任务的证据总结[J]. 中华护理杂志, 2020,55(9):1412-1419.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2020.09.026.
[25] Blaylock A, Cason C L. Discharge planning predicting patients' needs[J]. J Gerontol Nurs, 1992, 18(7): 5-10. DOI: 10.3928/0098-9134-19920701-05.
[26] 江雅倩, 汪晖, 刘于, 等. 出院计划综合需求评估量表的编制与信效度检验[J]. 护理实践与研究, 2022,19(19):2988-2991. DOI:10.3969/j.issn.1672-9676.2022.19
[27] 北京护理学会骨科专业委员会, 中华医学会骨科学分会护理学组, 中华医学会创伤学分会护理学组. 中国老年髋部骨折围手术期护理专家共识(2023)[J]. 中华创伤骨科杂志, 2023, 25(5):369-379.DOI:10.3760/cma.j.cn115530-20230104-00004.
[28] Alper E. Hospital discharge and readmission[EB/OL]. UpToDate, 2025-05-21[2026-05-07]. https://www.uptodate.com/contents/hospital-discharge-and-readmission
[29] 张咪, 周春兰, 吴艳妮, 等. 老年髋部骨折术后患者家庭康复护理的最佳证据总结[J]. 中华护理杂志, 2022,57(22):2777-2783.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2022.22.014.
[30] NICE. Hip fracture: management[EB/OL]. (2023-01-06)[2025-10-13]. https://www.nice.org.uk/guidance/cg124.
[31] Kane RL. Finding the right level of posthospital care: "We didn't realize there was any other option for him"[J]. JAMA, 2011,305(3):284-293.DOI:10.1001/jama.2010.2015.
[32] Jones C D, Cumbler E, Honigman B, et al. Hospital to post-acute care facility transfers: identifying targets for information exchange quality improvement[J]. J Am Med Dir Assoc, 2017,18(1):70-73.DOI:10.1016/j.jamda.2016.09.009.
[33] Adler-Milstein J, Raphael K, O'Malley T A, et al. Information sharing practices between us hospitals and skilled nursing facilities to support care transitions[J]. JAMA Netw Open, 2021,4(1):e2033980.DOI:10.1001/jamanetworkopen.2020.33980.
[34] Health Service Executive. HSE code of practice for integrated discharge planning[R/OL]. (2008-11)[2025-10-15]. https://www.hse. ie/eng/services/publications/hospitals/code-of-practice-for-integrated-discharge-planning.pdf
[35] Mennuni M, Gulizia M M, Alunni G, et al. ANMCO position paper: hospital discharge planning: recommendations and standards[J]. Eur Heart J Suppl, 2017,19(Suppl D):D244-D255. DOI:10.1093/eurheartj/sux011.
[36] Agency for Healthcare Research and Quality (US). Making healthcare safer IV: a continuous updating of patient safety harms and practices[R]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2023.
[37] 周起, 武文斌. 团体标准T/CAWAORG 004-2023《老年患者出院准备服务指南》解读[J]. 中国老年保健医学, 2024,22(6):57-61.DOI:10.3969/j.issn.1672-2671.2024.06.012.
[38] Yu S F, Cheng J S, Chen Y C, et al. Adherence to anti-osteoporosis medication associated with lower mortality following hip fracture in older adults: a nationwide propensity score-matched cohort study[J]. BMC Geriatr, 2019,19(1):290.DOI:10.1186/s12877-019-1278-9.
[39] Fu Ying, Zhu Lijuan, Li Dacheng, et al. Evidence-based intervention on postoperative fear, compliance, and self-efficacy in elderly patients with hip fracture[J]. World J Clin Cases, 2022, 10(10):3069-3077.DOI:10.12998/wjcc.v10.i10.3069.
[40] Malafarina V, Reginster J, Cabrerizo S, et al. Nutritional status and nutritional treatment are related to outcomes and mortality in older adults with hip fracture[J]. Nutrients, 2018,10(5):555. DOI:10.3390/nu10050555.
[41] 张华果, 司文腾, 何宇迪, 等. 老年髋部骨折术后患者跌倒恐惧心理体验的质性研究[J]. 中华护理杂志, 2021,56(4):527-533. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2021.04.008.
[42] 金秀. 延续性护理方案在老年骨质疏松性髋部骨折术后患者中的应用研究[J]. 当代护士(下旬刊), 2023,30(2):88-91. DOI:10.19793/j.cnki.1006-6411.2023.06.024.
[43] 刘娅, 董桂平, 吴梅, 等. 老年早期糖尿病肾脏病患者出院准备服务的循证证据总结[J]. 中国临床保健杂志, 2025,28(2):266-274.DOI:10.3969/J.issn.1672-6790.2025.02.024.
[44] Tian Miao, Wang Zhijia, Zhu Yanbin, et al. Incidence, causes, and risk factors of unplanned readmissions in elderly patients undergoing hip fracture surgery: an observational study[J]. Clin Interv Aging, 2023,18:317-326.DOI:10.2147/CIA.S395012.
[45] 蔡迎佳, 徐珍瑾, 唐宏伟, 等. 行为目标达成度理念指导下的随访护理干预对髋部骨折人工关节置换术患者的影响[J]. 护理实践与研究, 2025,22(5):760-766. DOI: 10.3969/j. issn. 1672-9676.2025.05.020.
[46] 魏贝贝, 王斐, 周丽莉, 等. 老年髋部骨折术后患者随访清单的制订与应用研究[J]. 中华护理教育, 2025,22(5):604-610. DOI:10.3761/j.issn.1672-9234.2025.05.015.
[47] 王礼宁, 李新艳, 朱弈桦, 等. 老年髋部骨折术后二次骨折风险预测模型的构建与验证[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2025,18(1):49-59.DOI:10.3969/j.issn.1674-2591.2025.01.006.

(收稿日期:2025-11-12)
(本文编辑:张朔)

中国脆性骨折联盟,北京围手术期医学学会老年骨科护理与康复专业委员会,湖南省护理学会骨科专业委员会. 老年髋部骨折患者出院准备服务计划专家共识[J]. 骨科临床与研究杂志,2026,11(5):322-328.DOI:10.19548/j.2096-269x.2026.05.002.